

TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD

PRESENTACIÓN ACADÉMICA



INTEGRANTES:

Fabiola Meléndez
Alexandra Alabarca
Patricia Ferrer
Ann Arjona

Reflexiones



“

“Las conductas teatrales y búsqueda constante de atención en la personalidad histriónica funcionan como estrategias interpersonales aprendidas para obtener validación emocional y mantener cercanía afectiva.”

- **Theodore Millon**, Disorders of Personality (1996)

“

“Las personalidades histriónicas suelen desarrollar una sensibilidad marcada hacia la respuesta emocional de los demás debido a experiencias tempranas donde el afecto fue vivido como inconsistente o condicionado.”

- **Nancy McWilliams**, Psychoanalytic Diagnosis (2011)

Causas del Trastorno Histriónico de la Personalidad

PERSPECTIVA BIOPSICOSOCIAL



El Trastorno Histriónico de la Personalidad (THP) tiene un **origen multifactorial**.

La interacción de factores **biológicos, psicológicos y sociales** moldea su desarrollo y expresión.

La búsqueda de **aprobación externa** puede convertirse en el principal **regulador de la autoestima**.

Comprender estas causas permite **intervenciones más empáticas y efectivas**.



Implicación clínica: Evaluar la historia de desarrollo, los vínculos significativos, los modelos observados y el contexto cultural es esencial para una comprensión integral y un abordaje terapéutico centrado en la regulación emocional y la identidad.

Hipótesis clínica central

PERSPECTIVA BIOPSICOSOCIAL

-  vacío
-  inseguridad
-  rechazo
-  invisibilidad

“Necesito ser visto para sentir que valgo.”

-  aprobación
-  atención
-  validación
-  admiración
-  reconocimiento



Cuando la mirada externa se convierte en la principal fuente de valor personal, el otro pasa de ser un vínculo a convertirse en un **regulador de la autoestima y la seguridad emocional**.

Esta dinámica puede consolidar la **dependencia de la aprobación**, intensificar el **miedo al rechazo** y perpetuar el sentimiento de **vacío** cuando esa mirada no está presente.

El trabajo terapéutico busca favorecer la construcción de una **mirada interna estable, compasiva y autónoma**.



Implicación clínica: Abordar esta hipótesis permite intervenir los patrones de búsqueda de validación, fortalecer la autoestima y promover una identidad más integrada y resiliente.

Factores de riesgo asociados

PERSPECTIVA BIOPSIICOSOCIAL



Resumen importante: Estos son factores de riesgo, **no causas deterministas**.

La trayectoria de cada persona está influida por múltiples variables y puede modificarse mediante experiencias de apoyo, autoconciencia y regulación emocional.



Criterio general DSM-5-TR

MARCO CLÍNICO DIAGNÓSTICO



PATRÓN PERSISTENTE DE EMOCIONALIDAD EXCESIVA Y BÚSQUEDA DE ATENCIÓN



Inicio en la **adultez temprana**.



Presente en **diversos contextos**.



Debe generar **deterioro funcional** o **malestar clínico**.



La presencia de **5 o más criterios** apoya el diagnóstico del Trastorno Histriónico de la Personalidad, siempre que se cumplan el **patrón general** y se descarte que los síntomas sean mejor explicados por **otra condición**.

No todo rasgo es trastorno

PERSPECTIVA BIOPSIICOSOCIAL



Rasgo normal

- ✓ expresividad
- ✓ carisma
- ✓ teatralidad
- ✓ sociabilidad



Trastorno

- ✓ rigidez
- ✓ persistencia
- ✓ deterioro
- ✓ malestar
- ✓ conflictos



El diagnóstico requiere **juicio clínico**, no solo observación superficial.

Los rasgos de personalidad existen en un **continuo**.

Se considera trastorno cuando son **rígidos, inflexibles** y generan **deterioro significativo** en el funcionamiento y malestar clínico.

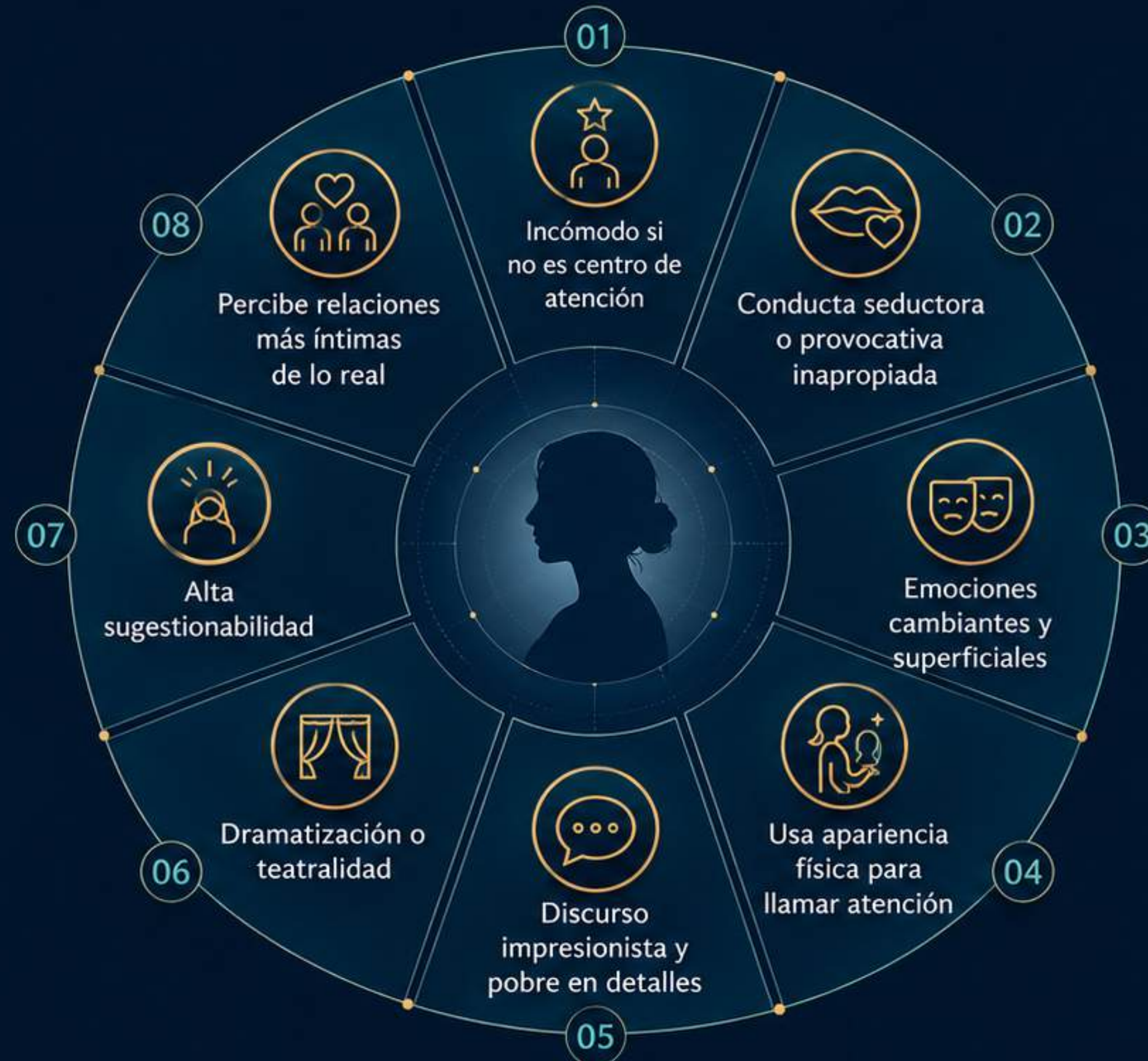
El **contexto**, la **cultura** y la **historia de vida** son esenciales para una comprensión integral.



Implicación clínica: Diferenciar entre variaciones normales y trastorno evita la sobremedicalización, reduce el estigma y permite intervenciones más precisas, éticas y centradas en la persona.

Criterios clínicos principales

PERSPECTIVA BIOPSICOSOCIAL



Se requieren
**al menos
5 criterios**
para el diagnóstico.



Cuadro Comparativo del Trastorno Histriónico de la Personalidad



DSM-5 TR



Excesiva emotividad y búsqueda de atención.



Interacción con los demás caracteriza por comportamientos inapropiados, conductas sexualmente seductora o provocativa.



Muestra emociones superficiales y cambiantes.

VS

CIE-11



Evaluación de la Afectividad Negativa si hay inestabilidad emocional.



Se manifiesta a través del rasgo de impulsividad y necesidad de validación externa.



Puede incluirse en el dominio de Desinhibición (falta de control de impulsos).



Ambos sistemas reconocen la búsqueda de atención y la inestabilidad emocional, pero desde enfoques diagnósticos diferentes.





Diagnóstico Diferencial



Trastorno Histriónico de la Personalidad (F60.4)

 Trastornos	 Similitudes	 Diferencias
 Otros T.P.	Puede cumplir criterios diagnósticos para uno o más trastornos de personalidad además del THP; pueden coexistir varios diagnósticos.	El diagnóstico principal dependerá del patrón predominante, la estabilidad de los rasgos, el nivel de deterioro funcional y la evolución clínica.
 TLP	Búsqueda de atención, comportamiento manipulador y emociones cambiantes o intensas.	En el TLP suele haber autodestrucción, crisis intensas en relaciones cercanas, sentimientos crónicos de vacío y alteración de la identidad; estos elementos no son nucleares en el THP.



Diagnóstico Diferencial

Trastorno Histriónico de la Personalidad F60.4

Trastornos	Similitudes	Diferencias
 T. Antisocial	✓ Impulsividad, superficialidad, búsqueda de emociones, temerarios, seductores, manipuladores.	➔ THP exagera más sus emociones, no se involucran característicamente en conductas antisociales.
 TNP (Narcisista)	✓ Buscan atención de los demás.	➔ TNP elogios por “superioridad”, THP está dispuesto a parecer “frágil o dependiente”.
 T.P. Dependiente	✓ Depende excesivamente de recibir elogios.	➔ TDP no presenta características emocionales extravagantes.



El diagnóstico diferencial requiere evaluación clínica integral, considerando el contexto, historia de vida y patrones de funcionamiento.





Diagnóstico Diferencial

Trastorno Histriónico de la Personalidad F60.4



TRASTORNOS	SIMILITUDES	DIFERENCIAS
 Cambio de p. debido a otra condición médica	 Los síntomas pueden parecerse a los del THP, dependiendo de la condición médica.	 Los rasgos de p. emergen como consecuencia fisiológica directa de otra afección médica.
 T. por uso de sustancias	 Los síntomas pueden simular rasgos del THP durante la intoxicación o abstinencia.	 Distinguir síntomas que pueden desarrollarse en asociación con consumo persistente de sustancias.



El diagnóstico diferencial es esencial para evitar **sobrediagnóstico** y **subdiagnóstico**.
Requiere evaluación clínica integral y contextualizada.





Estadísticas actuales Nacionales e internacionales del Trastorno Histriónico de la Personalidad

Estadísticas y Prevalencia del Trastorno Histriónico de la Personalidad (THP)

1 Prevalencia Mundial



El THP afecta aproximadamente entre **1 % y 3 %** de la población general.



La prevalencia clínica promedio más citada es cercana al **2 %**.



Aunque no es uno de los trastornos más frecuentes, puede afectar significativamente la vida emocional y social de las personas.



Las cifras pueden variar según el país, el método de evaluación y la población estudiada. El diagnóstico clínico requiere evaluación profesional integral.





Estudios Epidemiológicos Internacionales



- **En Estados Unidos**, estudios epidemiológicos reportan una prevalencia aproximada de **1.84%**.



- **Investigaciones en población universitaria latinoamericana** han encontrado cifras de hasta **4.3%**.



- **En América Latina** todavía existen pocas investigaciones específicas sobre este trastorno.



- Algunos estudios realizados en Colombia encontraron cifras de hasta **4.3%** en determinadas poblaciones evaluadas.



- *Las cifras pueden variar según el país, el método de evaluación y la población estudiada. El diagnóstico clínico requiere evaluación profesional integral.*





Sexo y Edad



1

Anteriormente se diagnosticaba con mayor frecuencia en **mujeres**.



2

Actualmente se considera que puede presentarse tanto en **hombres** como en **mujeres**.



3

Estudios recientes indican que el THP puede manifestarse de manera similar en **ambos sexos**.



4

Los síntomas suelen comenzar al final de la **adolescencia** o inicio de la **adultez**.



Las manifestaciones pueden variar según el contexto cultural, social y las experiencias individuales de cada persona.



Panamá y el Trastorno Histriónico de la Personalidad



- **En Panamá no existen actualmente estudios** oficiales específicos sobre la prevalencia del THP.



- **Especialistas en salud mental** consideran que las cifras nacionales probablemente sean similares a las internacionales.



- **La prevalencia estimada internacionalmente** se mantiene entre **1% y 3%** de la población general.



- **La falta de estadísticas específicas** no disminuye la importancia clínica y social de este trastorno en Panamá.



Se requiere fomentar la investigación y el registro sistemático para comprender mejor el impacto del THP en la población panameña y mejorar la atención en salud mental.





Panamá y el Trastorno Histriónico de la Personalidad



El Trastorno Histriónico de la Personalidad continúa siendo un trastorno con **pocas estadísticas específicas** en muchos países, incluyendo **Panamá**. Sin embargo, las investigaciones internacionales permiten **estimar su prevalencia** y comprender su **impacto clínico**.





Investigaciones científicas recientes sobre THP



1. Proceso de cambio en la psicoterapia para pacientes que presentan trastorno histriónico de la personalidad. **Babl et al. (2023)**

 Desea conocer	 Hallazgos principales
1 ¿Cómo cambian los pacientes con THP durante la psicoterapia?	1 Los pacientes con THP sí pueden mejorar significativamente con psicoterapia.
2 ¿Qué procesos psicológicos producen mejoría?	2 La alianza terapéutica es esencial para el cambio y la evolución clínica.
3 ¿Qué intervenciones terapéuticas funcionan mejor?	3 Trabajar validación emocional y relaciones interpersonales reduce síntomas y mejora el funcionamiento. 4 Detrás de la dramatización suele haber inseguridad emocional profunda.





Investigaciones científicas recientes sobre THP



2. “Trastornos de Personalidad del Cluster B: Presentaciones Límitrofe, Histriónicas y Narcisistas en la Práctica Clínica”. Wanderi et al (2026)

Desea conocer		Hallazgos principales	
	1. Diferencias y similitudes entre Trastornos Cluster B	1	El THP frecuentemente se confunde con TLP y TNP
	2. Dificultades Diagnósticas	2	Muchos pacientes muestran rasgos mixtos
	3. ¿Cómo se presentan clínicamente los pacientes?	3	Los modelos dimensionales modernos son más útiles que categorías rígida



Estos hallazgos apoyan un enfoque diagnóstico más flexible y personalizado, fundamentado en la comprensión integral del paciente.



Investigaciones científicas recientes sobre THP



3. “La eficacia de la terapia de esquemas para los trastornos de personalidad: una revisión sistemática y metaanálisis.” Zhang et al (2023)

Desea conocer		Hallazgos principales	
	1 Si la terapia de esquemas es efectiva en TP	1 	La terapia de esquemas reduce síntomas de los TP
	2 ¿Qué síntomas mejoran más con este tratamiento?	2 	Mejora regulación emocional y autoestima.
	3 ¿Cómo afecta relaciones interpersonales y regulación emocional?	3 	Ayuda a modificar patrones interpersonales disfuncionales.
	4 ¿Qué tan sólida es la evidencia científica actual?	4 	Mejora funcionamiento social y calidad de vida.
		5 	Tiene evidencia prometedora para trastornos del Cluster B.



La terapia de esquemas muestra eficacia significativa en síntomas centrales del THP, con beneficios sostenidos en el tiempo y evidencia prometedora en trastornos del Cluster B.





Investigaciones científicas recientes sobre THP



4. “La epidemiología global de los trastornos de personalidad: una revisión sistemática y metarregresión”. Shadid et al (2025)

Desea conocer	Hallazgos principales
 1. Prevalencia global de los TP	 1. Los TP siguen siendo altamente prevalentes a nivel mundial
 2. ¿Cómo varían entre países y poblaciones?	 2. Existe superposición entre diferentes TP
 3. Relación entre TP y otros problemas de salud mental	 3. Los modelos dimensionales describen mejor la realidad clínica actual
 4. ¿Qué tan útiles siguen siendo los modelos diagnósticos tradicionales	 4. Los TP frecuentemente coexisten con ansiedad, depresión y trauma
 5. Relevancia de modelos dimensionales modernos como el DSM-5 alternativo o CIE-11	 5. La psiquiatría moderna se está moviendo hacia evaluaciones basadas en rasgos y severidad.



La investigación reciente confirma que los trastornos de personalidad son comunes, complejos y heterogéneos. Los enfoques dimensionales y basados en rasgos ofrecen una comprensión más precisa y clínica de estos trastornos.



FAMOSOS Y TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD

Enfoque clínico, ético
y basado en evidencia



AVISO ÉTICO Y CLÍNICO



No es ético diagnosticar a celebridades sin evaluación clínica directa.



La mayoría de listas en internet son especulativas y poco profesionales.



El diagnóstico de trastorno de personalidad requiere entrevista clínica, historia longitudinal, funcionamiento y diagnóstico diferencial.



Hablaremos de casos con evidencia pública confirmada o de rasgos observables, no de diagnósticos definitivos.



Los trastornos de personalidad son complejos y multifactoriales.



La fama implica exposición mediática, no implica patología.

CASO PÚBLICO CON EVIDENCIA

AMBER HEARD



Durante el juicio civil de Deep vs. Heard, la psicóloga forense Shanno Curry testificó que su evaluación apoyaba diagnósticos de Trastorn Límite y Trastorno Histriónico de la Personalidad.



Reportado por medios confiables como AP News y The Guardian

¿Qué es un testimonio forense?

- Es una opinión experta basada en evaluaciones para un juicio.
- No sustituye un proceso clínico completo.
- Puede estar influenciado por el contexto legal, no solo clínico.

Cuadro comparativo: famosos, evidencia y rasgos observables

 NOMBRE	 EDAD	 EVIDENCIA DISPONIBLE	 RASGOS QUE PODRÍAN PARECERSE AL THP	 EN QUÉ PUDO VERSE AFECTADA SU IMAGEN PÚBLICA O CARRERA
Amber Heard	40	Testimonio forense público durante el juicio Depp vs. Heard.	Búsqueda de atención, emocionalidad intensa, relaciones interpersonales conflictivas.	Alta exposición mediática, polarización social y escrutinio profesional.
Madonna	67	No hay diagnóstico público confirmado de THP.	Provocación estética, reinención constante, control de la atención pública.	Controversias mediáticas, pero también fortalecimiento de su imagen artística.
Lady Gaga	40	No hay diagnóstico público confirmado de THP.	Teatralidad escénica, vestuario impactante, dramatización artística.	Reforzó su marca artística como figura creativa, disruptiva y performativa.
Lindsay Lohan	39	No hay diagnóstico público confirmado de THP.	Alta exposición mediática, conducta pública llamativa, relaciones con fuerte cobertura de prensa.	Problemas legales, críticas públicas y afectación temporal de su carrera.
Marilyn Monroe	Falleció a los 36	No hay diagnóstico público confirmado de THP.	Imagen pública seductora, glamorosa y orientada a la mirada social.	Su identidad pública fue simplificada por la industria como símbolo sexual.
Kanye West	48	No hay diagnóstico público confirmado de THP.	Teatralidad pública, provocación, búsqueda de impacto mediático.	Su personalidad pública ha generado controversias y en ocasiones ha eclipsado su obra artística.



Nota: Este cuadro no establece diagnósticos clínicos. Presenta evidencia pública o rasgos observables que pueden parecerse superficialmente al THP. Rasgo no equivale a diagnóstico. La fama, la teatralidad o la exposición mediática no constituyen por sí mismas un trastorno de personalidad.



Conclusiones



1

El **THP** se entiende actualmente como un trastorno relacionado con **regulación emocional**, necesidad de **validación** y dificultades **interpersonales**.



2

Las investigaciones actuales y modelos modernos como el **DSM-5-TR** y el **CIE-11** muestran que el THP frecuentemente comparte rasgos con otros trastornos del Cluster B, por lo que los **enfoques dimensionales** permiten diagnósticos más precisos y realistas.



3

Las estadísticas sobre THP en Panamá y Latinoamérica siguen siendo **limitadas** debido a falta de investigación regional, subdiagnóstico, acceso desigual a salud mental y posibles sesgos culturales y sociales que pueden influir en cómo se interpretan y diagnostican ciertos rasgos de personalidad.



4

Los estudios muestran que el THP puede **mejorar significativamente** mediante **psicoterapia especializada** enfocada en regulación emocional y relaciones interpersonales.



5

La evidencia actual muestra que la **terapia de esquemas** es una intervención efectiva para trastornos de personalidad, ya que ayuda a mejorar regulación emocional, autoestima, relaciones interpersonales y patrones de comportamiento disfuncionales, especialmente en trastornos del Cluster B.





Formaciones En Línea en Terapia de Esquemas





TERAPIA DE ESQUEMAS

FORMACIÓN INTERNACIONAL

CON RESPALDO DEL ISST



08:30 AM / 1:30 PM
+ ASESORÍA



MATERIAL 2025 - 2026



MODALIDAD
ONLINE INTENSIVA



A la vanguardia de la
terapia de esquemas en
América del Sur



+51 971 526 987



info@esquemasperu.com



www.esquemasperu.com



Dr. Edgar Rodríguez
DIRECTOR DE ITEP
47 años de Experiencia Clínica Formativa

EN PROGRAMA EN LÍNEA

FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL **ISST** TERAPIA DE ESQUEMAS

SOYIMTE.COM



10:00 AM A 02:00 PM
05 DE SEPTIEMBRE
DEL 2026
2 Sábados al mes



IMTE



Estas formaciones en línea ofrecen contenido actualizado, respaldo internacional y certificación para profesionales de la salud mental interesados en especializarse en terapia de esquemas.



Bibliografía

- 1 **American Psychiatric Association.** (s.f.). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (DSM). American Psychiatric Association.
- 2 **Babl A, Gómez Penedo JM, Berger T, Schneider N, Sachse R, Kramer U.** Change processes in psychotherapy for patients presenting with histrionic personality disorder. *Clinical Psychology & Psychotherapy*. 2023;30(1):64-72.
https://www.researchgate.net/publication/361686357_Change_processes_in_psychotherapy_for_patients_presenting_with_histrionic_personality_disorder
- 3 **Carvalho, L. de F., Gonçalves, A.P., Pianowski, G., Zuanazzi, A.C., & Franco, G.C.** (2025) Discriminating the histrionic personality disorder through the recognition need factor from the Dimensional Clinical Personality Inventory-2 (IDCP-2). *ResearchGate*.
<https://doi.org/10.15446/rcp.v34n2.103427>





Bibliografía



4

Cherry, K. (2024). Histrionic personality disorder: Signs, symptoms, and treatment options. *Verywell Mind*. <https://www.verywellmind.com/histrionic-personality-disorder-8754100>



5

Fariba KA, Gupta V, Torrico TJ, et al. Personality Disorder. [Updated 2024 Jul 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556058/>



6

Fowler, K. A., & Lilienfeld, S. O. (2025). Histrionic personality disorder (HPD). In EBSCO Research Starters. EBSCO Information Services. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9743-histrionic-personality-disorder>



Bibliografía



7

Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá. Cuadro 16: Población con algún tipo de Discapacidad Física o Mental en la República de Panamá. Censo 2023.

<https://www.inec.gob.pa/archivos/P0774740120231009162832CUADRO%2016.pdf>



8

McWilliams, N. (2011). *Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the Clinical Process* (2nd ed.). New York: Guilford Press.



9

Millon, T. (1996). *Disorders of Personality: DSM-IV and Beyond* (2nd ed.). New York: Wiley.



Bibliografía



10



Nestadt G, Romanoski AJ, Chahal R, Merchant A, Folstein MF, Gruenberg EM, McHugh PR.

An epidemiological study of histrionic personality disorder. Psychol Med. 1990 May;20(2):413-22.

doi: 10.1017/s0033291700017724. PMID: 23562666.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23562666/>

11



Shadid J, Ferrari AJ, Bach B, Sellbom M, Sharp C, Hutsebaut J, d'Huart D, Santomauro DF, Chanen A.

The global epidemiology of personality disorder: a systematic review and meta-regression.

Lancet Psychiatry. 2025 Dec;12(12):932-946. doi: 10.1016/S2215-0366(25)00299-8.

Epub 2025 Nov 3. PMID: 41197646.

[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(25\)00299-8](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(25)00299-8)

12



Torrico TJ, French JH, Aslam SP, et al. Histrionic Personality Disorder.

[Updated 2024 Jun 20]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL):

StatPearls Publishing; 2026 Jan-. Available from:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5423325/>



Bibliografía



13

Wanderi, P. W., Gitu, M. W., Wasuna, N. A., Kamati, R. K., & Muthamia, S. N. (2026). Cluster B Personality Disorders: Borderline, Histrionic, and Narcissistic Presentations in Clinical Practice. Winsper C, Bilgin A, Thompson A, et al. The prevalence of personality disorders in the community: a global systematic review and meta-analysis. *The British Journal of Psychiatry*. 2020;216(2):69-78. doi: 10.1192/bjp.2019.166



14

World Health Organization (2025). *Mental health atlas 2024*. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/382452> License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO



15

Zhang K, Hu X, Ma L, Xie Q, Wang Z, Fan C, Li X. The efficacy of schema therapy for personality disorders: a systematic review and meta-analysis. *Nord J Psychiatry*. 2023 Oct;77(7):641-650. doi: 10.1080/08039488.2023.2228304. Epub 2023 Jul 4. PMID: 37402124.





¡MUCHAS GRACIAS!



Gracias por su atención



TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD
• PRESENTACIÓN ACADÉMICA •